

## 1. DATOS GENERALES:

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE: KEVIN ALEJANDRO VIZCAINO VILLERO                                    | H.C: 1066872807                  |
| EDAD: 17 Años                                                               | FECHA DE NACIMIENTO: 22/10/2007  |
| ESCOLARIDAD: Segundo semestre de licenciatura en educación física y deporte | FECHA DE EVALUACIÓN: 6,8/10/2025 |
| DIRECCION: MZ 72 CASA 11 A- VILLA DARIANA 2                                 | CORREO: Inpao.amor@hotmail.com   |
| EPS: Particular                                                             | EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega    |
| ACOMPAÑANTE: Madre                                                          | CELULAR: 3005012634              |

## 2. MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, el detonante fue el comportamiento de él, que no obedece las reglas de la case, tuvo en episodio del tema del vaper.

## 3. ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde hace dos años caracterizado por dificultades de comportamiento, no llega temprano a casa cuando sale hacer deporte, el comportamiento de la casa es diferente al de la casa, la madre agrega que no le tiene confianza, poco dialoga con ella, le cuesta la comunicación, la fluidez verbal, no quiere compartir en reuniones familiares, se aísla al cuarto, cuando están de paseo presenta similar comportamiento. Presenta adición en los videos.

Selectivo para comer, (como pollo en alitas, no come carne, cerdo, pescado).

Madre lo describe como tímido, sin embargo en situación de hurto del celular hace aproximadamente 5 años, respondió de manera activa saliendo detrás de los ladrones sin medir el peligro.

Hace aproximadamente 14 años los padres se separaron, la madre se siente culpable por la ruptura de la relación.

## 4. ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: No reporta.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

## 5. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: Primo en segundo grado con TDAH.

## 6. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, inadecuada higiene postural, reticente, poco colaborador, lenguaje concreto, necesidad de instigación, orientado alo y auto psíquicamente, bradilalico, bradipsiquico, tendencia distractica, no quejas de memoria, no alteraciones de sueño, no



alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.

## 7. PRUEBAS APLICADAS

Se realiza prueba de observación del ADOS 2 que permita conocer la comunicación e interacción social, patrón de comportamiento restrictivo y repetitivo, socialización a partir de: tarea de construcción, contar un libro, descripción de una imagen, conversación, escuela, dificultades sociales, emociones, tarea de demostración, viñetas, vida diaria, amistad y matrimonio, soledad, planes e ilusiones, inventarse una historia, descripción de una imagen, contar una historia de un libro, Juego libre, fiesta de cumpleaños.

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ADOS 2</b> | <b>Fluidez verbal</b><br><b>Adolescentes y adultos</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------|

### *Nuevo algoritmo módulo 4, ADOS-2*

| Lenguaje y Comunicación                                      | Ítems  | Puntaje Obtenido Algoritmo |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| Conversación                                                 | (A-8)  | 1                          |
| Gestos Enfáticos o Emocionales                               | (A-10) | 0                          |
| <b>Interacción Social Recíproca</b>                          |        |                            |
| Contacto visual inusual                                      | (B-1)  | 0                          |
| Expresiones Faciales Dirigidas al Examinador.                | (B-2)  | 0                          |
| Comunicación de sus Propias Emociones                        | (B-5)  | 1                          |
| Comprensión de las Situaciones y Relaciones Sociales Típicas | (B-7)  | 0                          |
| Características de las Iniciaciones Sociales                 | (B-9)  | 1                          |



|                                                                                            |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Calidad de la respuesta social                                                             | (B-11)                 | 1                     |
| Cantidad de Comunicación Social Recíproca                                                  | (B-12)                 | 1                     |
| Cualidad General de la Relación                                                            | (B-13)                 | 1                     |
| <b>Afectación social</b>                                                                   | <b>Total</b>           | <b>6</b>              |
| <b>Comportamiento Restringido y Estereotipado</b>                                          |                        |                       |
| Anormalidades del Habla Asociadas al Autismo                                               | (A-2)                  | 0                     |
| Uso Estereotipado/idiosincrásico de palabras o frases                                      | (A-4)                  | 0                     |
| Interés Sensorial Inusual en los Materiales de Juego o en las Personas.                    | (D-1)                  | 0                     |
| Manierismos de manos y dedos y Otros manierismos Complejos                                 | (D-2)                  | 0                     |
| Interés Excesivo o Referencias a Temas u Objetos inusuales                                 | (D-4)                  | 0                     |
| <b>Comportamiento Restringido y Estereotipado</b>                                          | <b>Total</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Afectación Social y CRR (Punto de Corte para considerar diagnóstico de Autismo = 8)</b> | <b>Total Obtenido</b>  | <b>6</b>              |
| <b>(Afectación social, Comportamientos repetitivos restringidos): Puntaje Comparativo</b>  | <b>Puntaje Global:</b> | <b>AS: 6/0 CRR: 6</b> |



| Cuestionario Check list TDAH                                                                                                                                                                                            |                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Criterios DSM 5                                                                                                                                                                                                         | A1 Inatento (3) Normal | A2 Hiperactividad/Impulsividad (2) Normal |
| Observación: Las puntuaciones superiores en la escala clínica a 5 puntos, son consideradas en riesgo, y una puntuación iguales o superiores a 6 puntos en la escala adaptativa se consideran un criterio de anormalidad |                        |                                           |

| Test de autismo para adultos (AQS) |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Resultado: 19 No autismo           |                                       |
| 65 a 112                           | Alta presencia de rasgos del autismo  |
| 40 a 64                            | Media presencia de rasgos del autismo |
| 0 a 39                             | Baja presencia de rasgos del autismo  |

## CONCLUSIONES

Parte del habla del individuo incluye algo de elaboración espontánea de sus propias respuestas a beneficio del examinador; da pautas y entradas al examinador para que pueda seguir la conversación, pero la cantidad de habla es menor a la esperada para el nivel de lenguaje expresivo del individuo o está limitada en cuanto a flexibilidad cognoscitiva, por momentos se muestra reticente, poco colaborador, presenta una actitud con poca apertura cognitiva, muchas de las respuestas carecieron de un nivel formal con tendencia a un pensamiento concreto con poco esfuerzo cognitivo.

El paciente mostro variedad de gestos enfáticos o emocionales bien integrados en el habla, sin afectación de la entonación pero con baja fluidez verbal semántica y fonológica que nos llevan a pesar a que posiblemente puede existir algún debilitamiento en los procesos de aprendizaje e inteligencia, así como de la competencia cognitiva.

Durante el desarrollo de las tareas existió contacto visual adecuado aunque no permanente, el uso de gorra o cachucha limita la expansión del contacto visual, así como la apertura para abrirse a otras personas; presenta una tendencia de persona solicitaría, con poco compromiso por sus responsabilidades y conducta de cambio ante los llamados de atención, con baja empatía por las demás personas y manifestaciones de conductas evitativas.

Por momentos el cribado se mostró poco colaborador, fue necesario la persuasión e instigación para logra que desarrollara las actividades, aunque con muy bajo esfuerzo cognitivo.

El paciente es capaz de dirigir variedad de expresiones faciales apropiadas al examinador y a la madre con la intención de comunicar emociones, aunque con una tendencia apática.

El paciente es capaz de hacer ciertas descripciones de haber sentido varias emociones, pero limitada en variedad o en capacidad para poder comunicarlas adecuadamente (puede transmitir una emoción de un modo efectivo), le cuesta hablar de sus relaciones interpersonales, es muy reservado mostrando



distancia si no existe una ganancia en lo que va a expresar con tendencia a tener poco respeto por las figuras de autoridad.

Es capaz de mostrar varios ejemplos de comprensión de la naturaleza de relaciones sociales típicas, incluyendo la comprensión de su propio rol en, al menos, una de ellas.

Presenta cualidad levemente inusual de algunos acercamientos sociales con el evaluador y la madre, pueden restringirse a demandas personales o estar relacionados con intereses propios del individuo, pero con alguna intención de incluir al examinador en ese interés, con interacción cómoda por momentos, pero no sostenida.

La interacción es unilateral o inusual convirtiéndose por momentos en muy básica para la edad, con algo comunicación social recíproca pero reducida en frecuencia o cantidad en número de contextos en los que se dan dichos comportamientos (independientemente de la cantidad de charla no social).

Se denoto entonación que varía apropiadamente, volumen razonable y velocidad normal del habla, con un ritmo regular coordinado con la respiración.

Rara vez o nunca uso palabras o frases estereotipadas o idiosincrásicas.

No realizo ninguna de las siguientes acciones: olisquear, tocar repetidamente, palpar texturas, lamer o morder, meterse algo en la boca, mostrar interés por repetir ciertos sonidos ni examinar visualmente algo de manera prolongada o inusual, sin embargo se debe hacer seguimiento a la selectividad con algunos alimentos los cuales obedecen a una falla sensorial propioceptiva que no fue tratada durante la infancia.

No se registró durante la evaluación manierismos de manos, dedos u otros manierismos complejos, así como nulo uso excesivo de intereses o referencias a objetos o temas inusuales o altamente específicos o restringidos.

Las conductas relacionadas con el bajo nivel de interacción y socialización pueden deberse a una afectación en los procesos de comprensión, estilo de afrontamiento y personalidad, al igual que el modelamiento visto en el uso de prendas de vestir lo cual lo colocan en riesgo de vulnerabilidad ya que puede ser fácil de persuadir o manipular por su grupo de amigos, a lo que se suma algunos comportamientos desadaptativos a la hora de mantener una conversación fluida.

## **PERFIL DEL PACIENTE**

Paciente con signos negativos de espectro del autismo aunque con dificultades en la interacción, socialización y comunicación pero que se relacionan con un estilo de personalidad evitativa, distante, con baja motivación e interés por participar de eventos sociales que no representa una ganancia, prefiere estar solo, a lo que suma la tendencia a las adicciones por las pantallas; existen dificultades en la integración sensorial con mayor deficiencia en la propiocepción.



Su conducta se caracteriza por apatía, poca receptividad, poca apertura cognitiva, reticencia, con baja motivación a la escucha o la modificación de las conductas, a lo que se suman bajas respuestas en la fluidez, tendencia al pensamiento concreto, bajo esfuerzo cognitivo en el desarrollo de las tareas, poco interés por el desarrollo de tareas, bajo rendimiento en tareas, respuestas básicas, poca aceptación de responsabilidades, mínima conducta de cambio, con posible afectación del indicador en comprensión verbal con alta necesidad de evaluación que nos permita comprender a mayor escala la comprensión verbal general, el razonamiento, la capacidad de memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y cociente general, toda vez que se percibe con alto riesgo de vulnerabilidad con alta necesidad de seguimiento e intervención.

## **IMPRESIÓN DIAGNOSTICA**

R418 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA FUNCION COGNOSCITIVA Y LA CONCIENCIA Y LOS NO ESPECIFICADOS.

## **PLAN DE INTERVENCIÓN**

Necesidad de evaluación de los procesos de inteligencia y aprendizaje, ya que existe algo riesgo de afectación por las bajas respuestas en las preguntas de abstracción y vocabulario.

Continuar proceso de rehabilitación dos veces por semana desde psicología clínica que permita desarrollar habilidades en la resolución de problemas, razonamiento ético; adopción de perspectiva, desarrollo de asertividad; auto instrucciones; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; entrenamiento en habilidades sociales, comportamiento prosocial, prevención de las adicciones.



**Jainer E. Guzmán Vega**  
Psicólogo - M.G Neuropsicología  
T.P 123096

Firma **U.S.B. - Medellín**

**Nombre del Profesional: Jainer Guzmán Vega**

**Especialidad: M.G Neuropsicología – USB de Medellín**

**No. Tarjeta Profesional:123096**

**Certificado internacional en ADOS 2**

